Número do processo: 0750661-30.2024.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: C. M. M. D. O.
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MANSUR DE OLIVEIRA

REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

S E N T E N Ç A

Cuida-se do processo de conhecimento que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional de natureza condenatória.

Na inicial, narra a parte requerente, menor impúbere, representada por seu genitor, que é beneficiária do plano de saúde "Amil 150 Nacional", com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Em 01/11/2024, foi diagnosticada com Hipopituitarismo (CID E23.0) e Puberdade Precoce Central (CID E22.8), necessitando do uso contínuo dos medicamentos SOMATROPINA RECOMBINANTE (Genotropin) e TRIPTORRELINA (Neodecapeptyl), conforme relatórios médicos acostados. Alega que a ré, operadora do plano, recusou-se a fornecer os medicamentos sob a justificativa de que seriam de uso domiciliar e, portanto, não obrigatórios segundo o Rol da ANS (RN 465/2021).

> "b) Seja provido, por meio do julgamento antecipado do mérito, em sua totalidade e em caráter definitivo, o pedido objeto da letra 'a' acima, sendo a Ré obrigada a custear o tratamento e fornecer os medicamentos Somatropina Recombinante (Genotropin) e Neodecapeptyl

(Triptorrelina), em exata conformidade com a prescrição efetuada pelo médico assistente da Autora e até a alta médica;

c) Considerando o reiterado descumprimento por parte do Plano de Saúde, seja a Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, consoante a Lei nº 9.656/98 e a jurisprudência pátria pacífica;" (ID 219387544, p. 20).

Deferida a gratuidade da Justiça em favor da autora, bem como deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e suporte todos os custos inerentes aos medicamentos Somatropina Recombinante (Genotropin) e Neodecapeptyl (Triptorrelina), a critério de uso e quantidade indicados pela médica assistente, observando-se inicialmente o esquema estampado nas receitas médicas de ids 218157814 e 218157815, assim como ordenada a citação (ID 219499389).

Citada a parte requerida (ID 220927511), que pugnou pela reconsideração da decisão de concessão da tutela de urgência (ID 221422607), mantida a decisão (ID 221435202), pugnado a parte pela apresentação de pedido médico atualizado para atendimento da determinação (ID 222693497).

Contestação no ID 224408401, oportunidade na qual, preliminarmente, requer a revogação da tutela de urgência concedida, argumentando ausência de laudo médico atualizado, bem como que os medicamentos pleiteados não constam do rol da ANS, tratando-se de fornecimento domiciliar, expressamente excluído da cobertura pelo contrato e pela legislação aplicável (art. 10, VI, da Lei 9.656/98). No mérito, sustenta que o fornecimento dos medicamentos não é obrigatório por não estarem previstos na cobertura mínima obrigatória, e que a responsabilidade pelo

fornecimento seria do SUS. Alega inexistência de falha na prestação do serviço que ensejasse indenização por dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Foi informado o deferimento de efeito suspensivo no bojo do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 224815152).

Réplica no ID 225581388, ocasião na qual a autora impugna a apresentação de duas contestações, requerendo o desentranhamento da segunda por preclusão consumativa. No mérito, refuta as alegações da defesa, reafirmando que os medicamentos estão sim contemplados no rol da ANS, conforme RN 465/2021, bem como nos protocolos clínicos do SUS e pareceres da Conitec. Argumenta que a jurisprudência dominante é no sentido da obrigatoriedade da cobertura, mesmo para medicamentos de uso domiciliar, quando essenciais ao tratamento da doença coberta pelo plano .

Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença (ID 225684632).

A parte requerida reiterou o pedido de reconsideração da decisão de concessão da tutela de urgência (ID 225912884). Por meio da decisão de ID 226269879 assinalou-se que já foi informado o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (que deferiu o pedido de tutela de urgência – ID 219499389) até julgamento de mérito do recurso (IDs 224815152 e 225305546).

Parecer do Ministério Público no ID 226631896, oficiando pela procedência dos pedidos iniciais.

Eis o relato. **D E C I D O.**

Inicialmente, registro a desnecessidade de abertura da fase instrutória, encontrando-se o feito apto a julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Em sede preambular, não obstante o pedido da autora para desentranhamento da peça de contestação, por alegada preclusão consumativa, não vislumbro hipótese de duplicidade de contestações ofertadas. Com efeito, a peça primeira de ID 221422607 se cuidou de pedido de reconsideração no tocante à tutela inicialmente deferida, ao passo que a segunda foi a peça de defesa de mérito (ID 224408401).

No mais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação processual, bem como os pressupostos processuais, passo à análise da matéria de fundo.

A controvérsia central reside em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer os medicamentos Somatropina Recombinante e Triptorrelina para tratamento de Hipopituitarismo e Puberdade Precoce Central prescrito à parte autora.

Sobre o tema, tem-se que a Lei nº 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Todavia, excepciona a obrigatoriedade de cobertura para os tratamentos e procedimentos que elenca, dentre os quais há previsão quanto a medicações de uso no ambiente domiciliar, nos seguintes termos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12**; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)

(....)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes**; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

(...)

> II - quando incluir internação hospitalar:
>
> (...)
>
> g) **cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar**; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

Emerge, pois, que o inciso VI do artigo 10 da indica Lei excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento.

Em igual sentido, estatuí o artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. **São permitidas as seguintes exclusões assistenciais**:
>
> (...)
>
> VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de

unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

(...)

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

(...)

IX - **quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes** (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;

X - **medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar**, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar

> relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...)

De outra banda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº 310/12, possibilitou a oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde para o tratamento de outras doenças, ditando que:

> Art. 3º As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na presente RN.
>
> (...)
>
> Art. 4º Para fins desta RN, são consideradas as seguintes definições:
>
> I - **Medicação de uso domiciliar**: aquela prescrita pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde;
>
> II - **Contrato acessório**: instrumento contratual, acessório ao contrato principal de plano privado de assistência à saúde, voltado para a cobertura de serviços adicionais de assistência à saúde, não previstos na Lei 9.656, de 1998, ou não integrantes do Rol Médico ou Odontológico de Procedimentos e Eventos em Saúde;
>
> Art. 5º **É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde a oferta de medicação de uso domiciliar por meio de contrato acessório**, nos termos do caput do art. 3º desta RN.
>
> Art. 6º A adesão dos beneficiários aos contratos acessórios de medicação de uso domiciliar é facultativa.

Consoante o referido normativo, a ampliação para oferta de medicação de uso domiciliar – ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral ou para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos – é acessória tem natureza facultativa.

A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados:

> APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tratamento do transtorno do espectro autista impõe tratamento e acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, de modo que se mostra ilegítima a restrição do número de sessões. A Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na esteira do entendimento jurisprudencial que ora se reafirma e que sucedeu à Resolução Normativa 428, previu a cobertura ilimitada de sessões no tratamento multidisciplinar para as pessoas com transtorno do espectro autista. 2. O acolhimento, em sede administrativa e antes do ajuizamento da ação, de parte da pretensão do autor, com a cobertura limitada do número de sessões anuais do tratamento multidisciplinar, afastada a ocorrência de lesão a interesse existencial concretamente digno de tutela, motivo pelo qual a pretensão por danos extrapatrimoniais deve ser desacolhida. 3. **O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de**

saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 3.1. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1601786, 07016251520218070004, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INDEFERIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE ÀS EXCEÇÕES LEGAIS NEM AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido para que o plano de saúde agravado forneça medicamentos e equipamento de uso domiciliar para controle de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10), que acomete o agravante há 27 (vinte e sete) anos, não encontra respaldo na legislação nem em precedentes judiciais. 2. **O art. 10 da Lei nº 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde. 3. Na mesma linha segue o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS disposto na RN nº 465/2021, salvo os medicamentos antineoplásicos orais para uso**

domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 4. Os medicamentos prescritos pelo médico para tratamento da diabetes que acomete o agravante são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções previstas na Resolução 465 da ANS, como os fármacos antineoplásicos. Também não há precedente do STJ que autorize a concessão dos medicamentos e aparelhos vindicados para uso domiciliar. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1715006, 07096558020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PERICARDITE. MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO NACIONALIZADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RECUSA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. TEMA 990 DOS JULGADOS REPETITIVOS. USO DOMICILIAR. 1. De acordo com o artigo 10 da Lei 9.656/98 e artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamentos importados não nacionalizados e sem registro na ANVISA. 2. Em 2018, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1712163/SP e 1726563/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 990), o STJ editou a seguinte tese vinculante: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA." 3. O entendimento vinculante do STJ restou embasado nos enunciados 6 e 26 da I Jornada do Direito à Saúde do CNJ. 4. A importação de medicamentos sem prévio registro constitui infração sanitária prevista no artigo 10,

IV, da Lei 6.437/77 e artigos 12 e 66 da Lei 6.360/76, além de infração penal tipificada no artigo 273 do Código Penal. 5. Não se mostra aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 657718 (tema 500), uma vez que se refere ao fornecimento de medicamentos pelo Estado. **6. Verificando-se que o contrato firmado entre as partes está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso**. 7. Ante a ausência de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. 8. Apelo conhecido e provido.

(Acórdão 1613308, 07314691920218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.)

Sem descurar dos precedentes em sentido diverso, no sentido de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em prover a medicação, mesmo em regime domiciliar, quando se trata de tratamento necessário à saúde do beneficiário e indicado por especialista, alinho-me ao entendimento no sentido de não haver obrigatoriedade da cobertura do medicamento de uso domiciliar fora das hipóteses legais (tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral ou para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos), inclusive envolvendo o medicamento SOMATROPINA. A esse propósito, cite-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. **SOMATROPINA**. NÃO OCORRÊNCIA ILEGALIDADE NA RECUSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3º do seu artigo 1.0125. Apelo conhecido e parcialmente provido. 2. **Conforme o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e o artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é legítima a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso**. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1707425, 07423346720228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. COBERTURA MÉDICA. MEDICAMENTO OMNITROPE (SOMATROPINA). IDADE ÓSSEA AVANÇADA. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO PELO PLANO. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Conforme artigo 2º da Lei Distrital nº 3.831/2006, a autarquia em regime especial INAS DF foi criada com a finalidade de "proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF".

2. A referida autarquia encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 27.231/2006, que, em seu Anexo IV, item 10, dispõe expressamente que está excluída da cobertura a medicação de uso domiciliar.

3. Considerando que a medicação Omnitrope (Somatropina) se trata de fármaco de uso subcutâneo domiciliar destinado a tratamento de idade óssea avançada, ou seja, não voltado a tratamento antineoplásico, conclui-se não haver obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde.

4. Ainda que a CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – tenha elaborado Relatório de Recomendação autorizando a incorporação da medicação em comento no âmbito do SUS, o caso concreto não discute fornecimento de medicamento no contexto do SUS - composto pelo Ministério da Saúde, Estados (Distrito Federal) e Municípios -, na medida em que a demanda se restringe a apurar a obrigatoriedade de o plano de saúde INAS DF custear a medicação.

5. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1921317, 0705388-62.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) (s.g.)

Volvendo a situação fática posta nos autos, o Relatório Médico encartado pelo requerente no ID 218157813 prescreve:

> "Embora apresente medidas normais de IGF1, com altura atual acima do - 2DP e, portanto, atualmente sem baixa estatura, a paciente teve piora da previsão de estatura na vida adulta (estimativa de altura atual calculada pelo método B Pinneau), ficando no limite inferior do alvo genético (161.5 cm+/- 6 cm)
>
> Apresenta quadro de puberdade fisiológica rapidamente progressiva com queda da previsão estatural. Neste caso é indicado iniciar Somatropina Recombinante na dose de 0,15 Ul/kg/dia ou 0,05 mg/kg/dia (1) associado a bloqueio com análogo LHRH.
>
> Essa conduta objetiva aumentar a velocidade de crescimento promovendo ganho estatural.
>
> Estudos mostram que pacientes com terapia combinada (análogo de LHRH e GH) a estatura final alcançada foi aproximadamente 7 cm maior do que a estatura predita antes do tratamento. Nos casos em que apenas o análogo LHRH foi usado o ganho estatural foi 4 cm. Portanto, a terapia combinada GH e análogo é eficaz em melhorar o ganho estatural (2). Neste caso, está indicado o uso de Somatropina Recombinante na dose de 0,05 mg/ kg/dia, o que equivale, associado ao bloqueio puberal realizado com análogo LHRH.
>
> A associação de Somatropina ao bloqueio puberal é uma opção reconhecida pelos especialistas para melhorar a velocidade de crescimento. Um estudo de 2021 comparando a associação de Somatropina Recombinante com análogo LHRH no tratamento da puberdade precoce em 10 meninas mostrou um ganho de 7,9 cm quando comparado a 1,6 cm com análogo LHRH isolado. Outros

> estudos mostraram um ganho adicional de 6 cm na terapia combinada quando comparado ao uso isolado de análogo LHRH (3).
>
> O bloqueio deverá ser mantido até 12 anos e 6 meses de idade óssea.
>
> Ressalto que o tratamento com Somatropina Recombinante e urgente, uma vez que o atraso no início do uso da medicação pode comprometer, de maneira irreversível, a altura final da paciente.
>
> O tratamento com GH deverá ser mantido até que idade óssea atinja 16 anos ou VC <2 cm/ano. O tratamento tem caráter de urgência. Reitero que o atraso no início do tratamento poderá comprometer a altura final e, portanto, a qualidade de vida da paciente."

Constato, pois, que a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representa medicação que não encontra previsão de cobertura obrigatório nem pela Lei nº 9.656/1998, nem pelo Contrato firmado, de modo que, com respeitosas vênias ao entendimento exarado pelo i. membro do Ministério Público, no parecer de ID 226631896, e das ponderações vertidas pelo i. patrono da parte autora, a negativa de cobertura se mostra lícita.

Por fim, no que atine ao pedido consistente na condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, à míngua de ato ilícito, inexiste a obrigação de indenizar, razão pela qual a improcedência também se impõe neste particular.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas, uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, por força do art. 85, § 2º, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar da data de distribuição da inicial; e de juros de mora, estes a contar da publicação desta Sentença, observada a Taxa Legal (Lei nº 14.905/2024), cuja vigência se iniciou em 30/8/2024.

ATRIBUO a esta Sentença força de ofício, a ser endereçado ao eminente Desembargador João Egmont, relator do Agravo de Instrumento de n. 0702817-53.2025.8.07.0000, por intermédio da ferramenta de comunicação entre órgãos PJe, para os fins que Sua Excelência entender pertinentes.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS

Juiz de Direito

Documento datado e assinado eletronicamente

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS
10/04/2025 18:00:41
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25041018003853600000210

IMPRIMIR GERAR PDF